<2021 년 본 3 학년말고사 - 산부인과>

총 **60 문제** 중 **60 문제** 복원

부인과 (28 문제) + 산과 (32 문제)

-> 야마를 타는 듯, 타지 않는 듯. 야마를 열심히 봐도 은근 헷갈리는 부인과 질환! 산과는 탈야마 조금 했습니다! 원래 부인과 문제가 더 많이 나온다고 생각했는데 역대급 산과 문제 수였던 것 같습니다.

당해 내신 야마를 꽤나 많이 탔습니다! 꼭 보고 들어가세요~

<부인과>

(1) 사춘기

1. 사춘기 조발증에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오.

1) Bone age 는 non dominant hand 나 elbow 에서 측정한다

2) 여성호르몬을 투여하여 치료한다

3) GnRH agonist 를 투여하여 이차 성징의 발현을 억제하는 것이 핵심이다

4) Bone age <12 세 일 때 사용하면 더 효과적이다

5) Epiphysis fusion 되거나, bone/chronologic age 가 일치할 때까지 치료한다

(2) 불규칙 월경

2. Hb 7.2, 질출혈 많이 있었다 해야 할 처치로 옳지 않은 것은?

1) 경구피임약을 7 일 간 하루 34 회 치료 후 용량을 줄여서 21 일 사용한다

2) 약물 치료가 되지 않으면 소파술을 한다

3) CEE 4 시간마다 25mg 투여

4) 수액 보충을 하면서 입원 치료를 한다

5) 우선 MPA 20mg 를 2 번 정도 투여한다

(3) 폐경

3. 56 세 여성 기저질환 없고 가족력 없고 홍조 불면증 호소 하는데 T score -2.7 임. 처치는?

1) E-P 호르몬 요법

2) 1 차 치료로 데노주맙을 쓴다

3) 1 차 치료로 calcitonin 을 쓴다

4) Vit D 600? Ca 준다 (각각 용량도 줬는데 기억 안남ㅠ)

5) Teriparatide 쓰다가 bisphosphonate 로 전환한다.

(4) IVF-ET

4. 32 세 여성 salphingogram 정상 사진 주고, 여성은 모두 정상이었음. 남성 정액 검사 2 번한 결과 주어짐 (각각 1 회/2 회 결과 값임)

ejaculate volume 1.3ml/0.5ml
sperm concentration 500 만/ml / 800 만/ml
motility 10%/15%
morphology 50% / 30%

처치는?

1) 체외수정 배아이식

2) 인공 수정 3 회 시도

3) 3-5 일 간 금욕후 정액검사 재검

4) 난관수종 수술

5) 클로미펜으로 배란 유도

5. 체외수정과 배아이식을 위해 과배란 유도에 대한 설명 틀린 것?

1) hCG 는 난자 성숙위해 난자 채취 전 34 36 시간에 투여

2) GnRH agonist 는 short protocol 이 long protocol 보다 임신률이 높다.

3) GnRH antagonist fixed protoco- 은
생식샘자극호르몬 투여 4~7 일 후에 투여

4) GnRH antagonist flexible protocol 은 난포 12-16mm 일 때 투여하면 황체호르몬 분비폭발을 막을 수 있다.

5) GnRH agonist 는 flare up secretion 없이 FSH, LH 분비를 억제할 수 있다는 장점이 있다.

(5) PID 및 감염질환

6. (21 생식 Y) 외음부 통증으로 내원한 환자이다. 서혜부 종괴는 만져지지 않았다. 사진은 아래와 같다. 적절한 처치는 무엇인가?



1) 아시클로버

2) 독시사이클린

3) 플루코나졸

4) 페니실린

4) 메트로니다졸

7. (Y) 65 세, 2-0-0-2 여성, 질 건조증, 소양증, 성교통으로 내원하였다. 54 세 폐경 이후 증상이 더 심해졌다고 한다. 소변과 질분비물 검사 및 자궁 경부 질세포진 검사는 정상이었다. 치료는?



1) 저용량 estrogen 질정

2) Prostaglandin inhibitor

3) 경구 메트로니다졸

4) 경구 독시사이클린

5) 클린다마이신 질크림

(6) 임신 융모질환

8. 산과력 0-0-2-0 인 30 세 여자가 질 출혈을 주소로 내원하였다. 자궁흡입긁어냄술 결과 완전포상기태를 확인하였고, hCG 검사 결과가 아래 표와 같았다. (야마와 다르게 점점 갈수록 감소하는 추세를 보였음) 흉부 X 선 검사 및 가슴컴퓨터 단층 촬영 소견이 정상이었다. 이 환자에게 해야 할 처치는?

[자궁흡입긁어냄술]

시행 전 120,000mIU/mL
1 주 후 60,000mIU/mL
2 주 후 45,000mIU/mL
3 주 후 20,000mIU/mL
4 주 후 9,280mIU/mL (정확하진 않고 9 천 얼마였음

① 자궁절제술

② 프로게스테론

③ 자궁흡입긁어냄술

④ 추적관찰

⑤ 복합경구피임제

*해설: hCG 가 정상 수치 계속해서 감소하고 있지만, 정상수치에 도달하지 않았기 때문이다. 아직 9 주가 안 됐기 때문에 추적관찰하게 되었다.

(7) 요실금

9. 39 세 여성이 맑은 질분비물을 주소로 내원하였다. 밤에 잠 잘 때도 나왔다. 3 개월 전 전자궁 및 양쪽 부속기 절제술을 받았으며, 수술 다음날 도뇨관 제거하였다. 질분비물에 대해 인디고카민 정맥 주사 후 질에 거즈를 대보니 파란색으로 염색 되었다. 가장 가능성 높은 진단은?

1) 방광질샛길

2) 긴장성 요실금

3) 절박요실금

4) 범람요실금

5) 과민성방광

(8) 피임법

10. 30 세 산과력 0-0-1-0 여성이 무월경으로 내원하여 hCG 검사를 시행한 결과 양성이었다. 이어서 시행한 초음파 검사에서 임신 11 주 상태이고, 검사 결과는 다음과 같다.

- 체온 36.3 도, 혈압 110/90, 심박수(정상), 호흡수 20
- 혈색소 10.3, 백혈구 7800/mm^3, 혈소판 380000

1 년전 자궁내장치 시술을 받았다고 했으나, 질경 검사에서는 자궁내장치의 실이 보이지 않았다. 적절한 조치는?



① 초음파 검사 하에서 자궁내장치 제거

② 입원 후 융모막 융모 생검

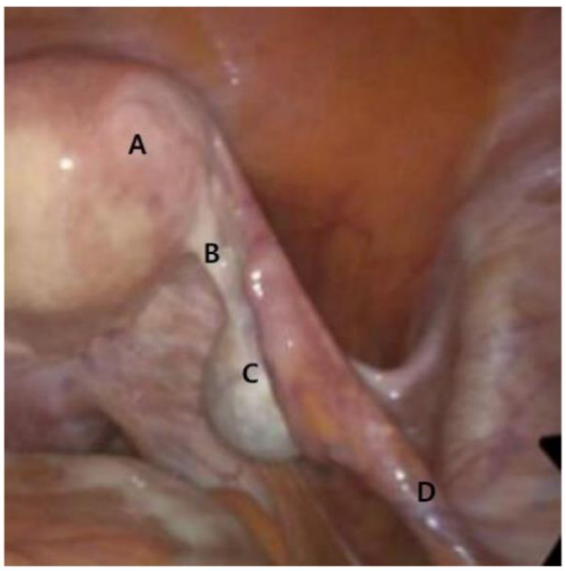
③ 프로게스테론 투여

④ 경과 관찰

⑤ 항생제 투여

(9) 수술사진 + 수술 과정

11. 다음 중 표시 한 구조물을 A-D 순서대로 나열한 것으로 옳은 것? (A-D 그림 indication 이랑 다르게 표시되어 있음



1) Rt.round ligament - Uterus - Right ovary - Right IP ligament

12. 자궁경부암 환자의 수술당시 사진이다. 다음 표시한 사진의 구조물은?



1) Left ureter

2) Left internal iliac vein

3) Left internal iliac artery

4) Left obturator nerve

5) Left uterine artery

13. 다음 중 peritoneal access 에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) Deep inferior epigastric vessel 의 손상을 피하기 위해 transillumination 을 이용한다.

2) Ancillary port 를 다시 삽입할 때에는 복강내압을 25mmHg 로 올린 후 수술이 끝나고 낮춘다.

3) 배꼽을 통해 접근할 때에는 Trendelenburg position 을 취한다.

4) 비만인 환자에서 복강내 진입을 위해서는 트로카를 거의 수직으로 삽입해야 한다.

5) 혈관이 관찰되지 않을 때에는 복직근의 중앙을 뚫고 들어간다.

(10) 자궁경부상피 종양 + 자궁경부암

14. 산과력 2-0-0-2, 32 세 여성 자궁경부 세포진 검사소견 상 아래와 같다. 환자에게 시행할 처치로 옳은 것은?

위치 : 상피세포
조직 소견 : HSIL
HPV : 18 번



1) LEEP

2) 전자궁적출술

3) 골반내용적출술

4) 정기적 추적관찰

5) 근치적 원추절제술

15. 2-0-3-2 산과력의 55 세 여성의 자궁경부에 2cm 정도의 출혈성 종괴가 있다. 다른 골반 진찰상 특이소견은 없었다. 출혈성 종괴에 대한 조직검사상 편평상피세포암 소견이 나왔다. 맞는 수술법은? (사진 2 장 있었음)

1) 광범위 자궁 적출술 & 양측 pelvic lymph 절제술

2) 골반내용 절제술

3) 단순 자궁 적출술 & 양측 pelvic lymph 절제술

4) 전골반 내용 적출술

5) 단순 자궁 적출술

16. 산과력 3-0-4-3 인 53 세 여성이 성교 후 질출혈을 주소로 내원하였다. 개인 의원에서 실시한 자궁경부 세포 검사 결과 HSIL 이 나왔다. 자궁 경부에 4cm 크기의 종괴가 관찰되었고, 질 확대경을 하자 궁경부 조직검사를 시행한 생검에서 침윤성 편평상피 세포암으로 진단되었다. 수술 전 촬영한 MRI image 는 다음과 같다. 다음으로 시행할 적절한 조치는? (자궁 경부 확대 사진이 하나 더 있었고 출혈 확인 가능했음)



1) 원추 절제술은 이미 시행했으므로 추가 치료없이 정기적 추적관찰만 시행한다.

2) Simple hysterectomy

3) 다시 laser conization 을 한다

4) 근치적 자궁적출술 + 골반림프절 절개 + 양쪽 난소난관절제술

5) 변형된 근치적 자궁적출술+골반림프절 절개

17. 산과 2-0-1-2, 60 세 여성이 자궁경부암으로 치료를 받았다. 근치적 자궁 절제술 및 배막뒤림프절절제술을 시행했었는데, 수술 소견은 다음과 같고 대동맥 근처 림프절은 전이되지 않았다. 병기와 다음으로 해야 할 처치를 고르시오.



1) IIIc1, 동시 항암화학방사선치료

2) IIIc2, 동시 항암화학방사선치료

3) IIIc1, 항암화학요법

4) IIIc2, 항암화학요법

5) IIc, 면역 요법

18. 산과력이 2-0-3-2 인 45 세 여성이 질출혈을 주소로 내원했다. 자궁경부세포진검사 상 HSIL 로 판명되어 원추절제술을 시행했다. 질경 검사 결과 깊이 2mm, 폭 6mm 인 자궁 경부에 침윤성 편평세포암종이 발견되었다. 더 이상 환자가 임신을 원하지 않는다고 할 때, 적절한 조치는? (자궁경부 사진은 각자 다른 사진이 제시되었는데 문제가 있는 사진이었습니다. 각각을 찾을 수 없어 같은 사진으로 대체합니다.)



1) 근치적 자궁적출술+골반 림프절 절개

2) 정기적 추적관찰

3) 변형된 근치적 자궁적출술+골반 림프절 절개

4) 단순 적자궁 적출술

5) 전골반내용적출술

(11) 부인 양성 질환

19. 다음 초음파 소견의 PALM-COEIN stage 소견은 무엇인가?



1) AUB-A

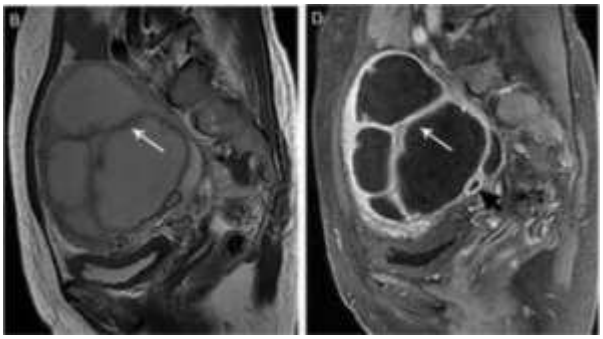
2) AUB-P

3) AUB-L

4) AUB-M

5) DUB

20. 산과력 2-1-0-2 인 28 세 여자가 하복부 통증을 주소로 내원하였다. 신체 진찰 결과 cervical motion tenderness (+)였다. 다음은 환자의 MRI 소견이다. 환자에게 필요한 처치는?



1) 전자궁 절제술

2) 입원하여 항생제 투여

3) GnRH agonist 투여

4) Oral contraceptive 투여

21. 36 세 여성 1-0-0-1 3 년전 2cm 근종 발견 지금 5cm 로 커짐. 생리 규칙적이나 통증으로 둘째 못가지는 중, MRI 로 근종 2 개 주고 처치는?

1) Observation

2) 근종절제술

3) 자궁절제술

4) HIFU

5) 프로게스테론

(12) Endometriosis / Endometrioma / Endometrial cancer

22. 47 세 3-0-1-2 여성, endometrial biopsy 결과에서 자궁내막암으로 확인되어 병기 결정 수술 진행하였다. 조직검사 결과는 다음과 같다.

조직 아형 : 유두상 점액성 선암
등급 : 3 등급
크기 : 2.7cm x 2.0 cm
자궁 근막 침습 : 18mm (자궁 근육 두께 19mm)
자궁 경부 : 침범하지 않음
우측 난소 : 전이성 유두상 점액성 선암
충수돌기 : 전이성 유두상 점액성 선암
paraaortic lymph node : 양성
pelvic lymph node : 양성
림프혈관강 침습 : 양성

치료는 ?

1) Brachytherapy

2) 골반외 방사선 치료

3) 경과 관찰

4) 복합항암치료

23. 29 세 미혼 여성, 성교통 및 질출혈로 내원하였다. 초음파 상에서 간유리음영의 낭종 확인되었고, 복강경 수술하였다. 우측 난소낭종제거술 후의 내시경 사진이며, 곧창자질사이막의 유착이 관찰되었다. 진단명은 무엇인가?





1) 자궁내막종 및 곧창자질사이막 자궁내막증

2) 자궁내막암

3) 자궁근종

4) 자궁샘근증

(13) 자궁외 임신

24. 산과력 2-0-2-2 인 36 세 여성환자가 6 주 째 무월경 및 복통을 주소로 내원하였다. 요임신검사 양성. 하복부 심한 통증과 압통 있었음. 더글라스 천자했더니 50mL 의 응고되지 않은 출혈 발견하여 응급수술함. 수술의 이름은? (사진은 자궁 전체 모습, 각각 좌우 adnexa 의 모습으로 총 3 장으로 보기에 나옴) (답논란)





1) 좌측 난관 절제술

2) 좌측 난소난관절제술

3) 우측 난관 절제술

4) 우측 난소난관절제술

5) 자궁절제술

(14) 난관 및 난소암 (benign + malignant)

25. 56 세 여성 난소암 종양감축술 받은 뒤 병리 검사 결과가 다음과 같다. 병기설정은?

Serous adenocarcinoma, moderately differentiated
Right & left ovary 모두 침범
Capsule 침범
Washing cytology (+)
Pelvic LN metastasis (+) : 7mm
Para-aortic LN metastasis (-)
Omentum & Omentectomy (-)

1) IIIA1(i)

2) IIIA1(ii)

3) IIIC1(ii)

4) IC1

5) IIB2

26. 17 세 여자 복부통증으로 응급실에 내원하였다.

CA125	216.6IU/mL
CA19-9	11.7IU/mL
aFP	14472ng/mL
b-hcg	<0.1mlU/mL

1) Endodermal sinus tumor

2) Dermoid cyst

3) Choriocarcinoma

4) Dysgerminoma

5) Immature teratoma

(14) 수술 전후 관리

27. 자궁적출술 및 BSO, PLND 받은 환자가 과거에 복부 수술 받아 유착이 심해서 수술시간이 오래 걸렸고 수혈도 받았다. 수술 2 일 후부터 흉통, 빈호흡을 호소하고 있다. 해야 하는 처치는?

1) aspirin

2) LMWH

3) 상체 거상

4) 항생제

5) 호흡보조요법

28. 개인병원에서 자궁적출술을 받은 환자가 의식소실을 주소로 응급실에 내원함. 수액 투여량 4000cc, 나온 양 1000cc. 뇌 CT, chest PA 사진 주어짐. 원인이 되는 distention media 로 옳은 것은?

1) Normal saline

2) Dextran 70

3) 3% sorbitol

4) 5% mannitol

5) 이산화탄소

<산과>

1. 환자가 치료받고자 하는 문제에 대해 시간 순으로 명시한 것. 어디가 아프고, onset, duration, 등등 언제 악화되고 언제 완화되는지 등등 알아보는 것과 관련된 사항은?

1) Present illness

2) Chief complaint

3) Initial assessment

4) Physical examination

5) Review of system

2. 임신 30 주의 28 세 임산부가 숨이 차고 다리가 부어 내원하였다. 혈압 110/80, 맥박 70/분, 호흡 25 회/분이었다. 복부촉진상 태아의 신체부위가 안 만져질 정도로 복벽이 팽팽하였고 자궁바닥의 높이는 38cm, 양수지수는 32 이었다. 처치는?

1) Indomethacin

2) 분만

3) 수분제한

4) Furosemide

3. 양수지수가 3cm 이고 IUGR 1750g (<5 백분위수). 자궁경부가 2cm 개대되어 있었으며 70% effacement 되어 있었다. 태아 doppler 검사에서 Reversed end diastolic flow 가 관찰되었다. 처치는? (NST 사진 제시되지 않고 말로만 설명되어있었습니다.)

1) 분만

2) 제왕절개

3) 경과관찰

4) 양수주입술

4. 임신 25 주인 34 세 미분만부가 산전 진찰을 위해 병원에 왔다. 검사 결과는 다음과 같았다. 혈액 50g OGTT 155mg/dL. 처치는?

1) 1 주 후 50g OGTT 재검

2) Insulin

3) 식이요법

4) 100g OGTT

5) 경과관찰

5. 임신 시 일어나는 모체의 생리적 변화로 옳지 않은 것은?

1) 유방의 크기와 모유생성량은 상관없다.

2) 임신시 질의 산도는 pH 3.5~6 으로 유지된다.

3) 임신 시 태아에 glucose 공급을 위해 약간 diabetogenic 한 상태가 된다

4) Angiotensin II 혈압상승 작용에 대한 저항성이 감소한다.

5) 임신시 Albumin 양이 저하된다.

6. 임신 시 일어나는 모체의 생리적 변화로 옳지 않은 것은?

1) 자궁의 크기는 임신 전 10mL 에서 임신 후 1100mL 까지 증가한다

2) 임신 8 개월에 자궁은 칼돌기높이까지 올라온다.

3) Pregnancy luteoma 는 모체의 남성화를 유발한다.

4) NO 가 강력한 혈관확장작용한다.

5) Uteroplacental blood flow 증가의 기본은 혈관확장 때문이다.

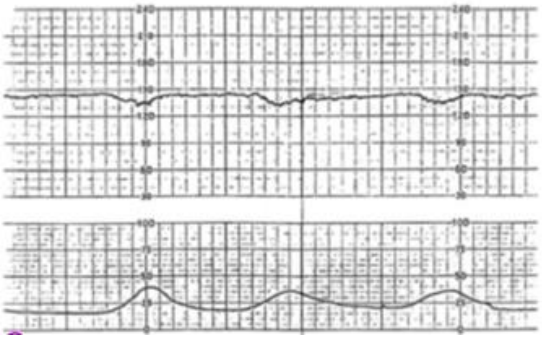
7. 29 세 임신 37 주의 임산부가 병원에 내원하였다. BPP 가 8 점이었고 AFI = 2cm 이었다. 조치는?

1) 분만

2) 경과관찰

3) 제왕절개

8. 임신 38 주 여성이 진통으로 내원하였다. 자궁 경부는 8cm 열려있었고 소실도 80%, 하강도는 +1 이었으며 양막은 파열되지 않았다. 비수축 검사가 다음과 같을 때 가장 적절한 원인은?



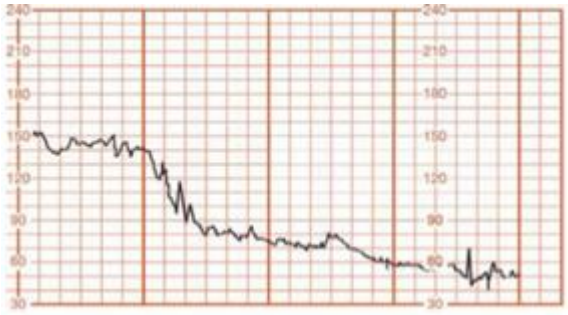
1) 태아두부압박

2) 제대압박

3) 태반기능부전

4) 양수과다

9. 임신 36 주 환자가 내원하였다. NST 는 다음과 같다. 자궁목 숙화는 일어나지 않았다. 처치는?



1) 제왕절개

2) 경과관찰

3) 유도분만

4) 옥시토신

5) 옆 누운 자세로 변경

10. 38 주, 35 세인 산모가 진통으로 내원하였다. 자궁경부 개대가 3cm, 자궁경부 소실도가 50%, 아두하강정도가 -2, 경부가 부드러웠으며, 경부의 위치는 anterior 였을 때, Bishop score 는?

1) 5

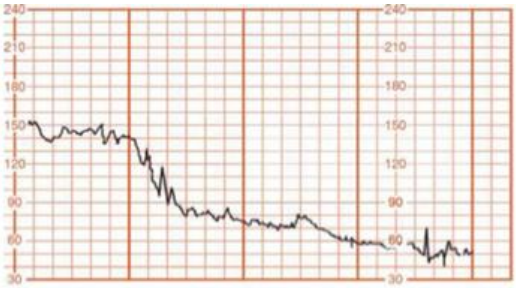
2) 6

3) 7

4) 8

5) 9

11. 다음과 같은 NST 가 관찰되는 과숙아 병태생리와 관련된 원인은?



1) 양수과소증

2) 과숙증후군

3) 두부압박

4) 태반부전

5) 거대아

12. 두정위 질식분만 중 cardinal movement 중에 extension 을 통해 태아의 머리가 질의 개구부와 회음부를 통과할 수 있어 분만이 원활하게 진행되게 하는 수기는?



1) Ritgen's maneuver

2) Muller's maneuver

3) Mauriceau's maneuver

4) McRobert's maneuver

5) Pinards' maneuver

13. 임신 39 주의 산모가 질식분만 후 다량의 질출혈이 계속되었다. 자궁저부는 배꼽 밑에서 단단하게 만져졌고, 만출된 태반 역시 정상이었다. 가장 가능성 높은 진단은?

1) 자궁목열상

2) 잔류태반

3) 자궁근무력증

4) 자궁내번증

5) 양수색전증

14. 34 세 임신 36 주인 산모가 심한 두통으로 내원하였다. 혈압 180/110mmHg, 단백뇨 (4+), 부종(2+,2+), 자궁 경부 1cm 개대, 80% 소실되었고 BPP 8 점이었다. 알맞은 처치는?

1) 분만

2) 옥시토신

3) 경과관찰

4) 제왕절개

15. 임신 중 고혈압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1) 확장기 혈압이 160mmHg 이상이면 ACE inhibitor 를 사용하여 130-150mmHg 로 낮출 수 있다.

2) 혈관 내피의 파괴에 의해 platelet 과 fibrin 의 침착으로 microangiopathic hemolysis 가 관찰된다.

3) 산모의 혈압이 높은 경우 태반조기박리 위험이 3 배 증가한다.

4) 저용량 아스피린을 추가하면 전자간증으로 진행을 예방할 수 있다

16. 가다실 2 차 접종까지 마치고 3 차 접종이 남은 여성이 임신 7 주로 판정되었으며 활력징후는 정상이었다. 옳은 설명은 (가나다라)

가) 인유두종 바이러스 백신은 임신 중에 접종이 가능하다

나) 인플루엔자 백신은 불활성화 백신으로 유행시기에 임신 중, 임신 전, 분만 후 모두 접종을 권고한다.

다) 풍진 백신은 불활성화 백신으로 임신 중에 접종 불가능하다.

라) 백일해가 유행하는 경우 임신 중이더라도 백신 접종을 할 수 있다.

1) 가나다라

2) 가나다

3) 가다

4) 나

5) 나라

17. 태아에 영향을 미치는 약물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

1) Paroxetine 노출 시 심장기형 위험이 1.5 배 증가하므로 임신 중 복용을 금해야 한다.

2) 리튬은 심장 기형을 발생시키며 출생 직전 사용 시 신생아 리튬 독성을 발생시키므로 분만 직전만이라도 복용 중단 후 출산한 후에 다시 복용할 것을 권고해야 한다.

3) 이소트레티노인은 임신 제 1 삼분기 노출 시 25-35%에서 기형을 발생시키는 것으로 neural crest cell 의 이동을 방해하여 소두증, 수두증, 소이증 등을 유발할 수 있고, 반감기가 12 시간으로 마지막 투여 후 7 일 이후로 임신을 계획해야한다.

4) 아시트레틴은 중증건선치료제로 임신 중 복용시 retinoid embryopathy 를 일으키므로 사용 시 철저히 피임을 해야하고 약제 중단 후 3 년 후 임신 시도를 권고해야 한다.

5) 와파린은 제 1 삼분기에 노출 시 골격계 이상, 안구이상 등을 일으키므로 임신 전기간 복용을 금지해야하므로 대안으로 헤파린을 사용해볼 수 있다.

18. 임신 전 상담을 하러 온 여성. 10 년 전 epilepsy 로 valproic acid 먹고 있음. 다음 중 틀린 것은?

1) 임신 3 개월 전부터 매일 엽산 0.4mg/day 를 먹어줘야 한다.

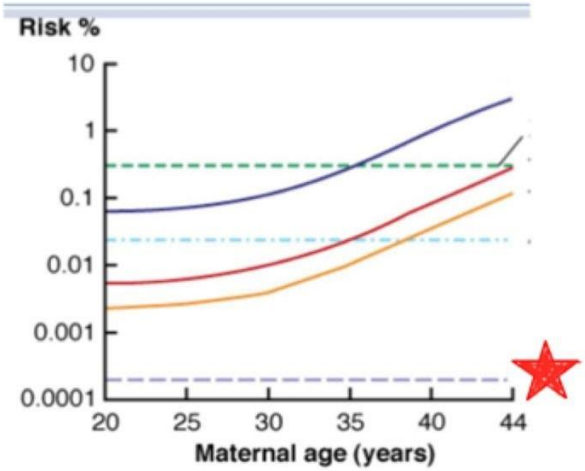
2) 임신 1 기 노출 시 기형 발생위험률 9.3% 증가한다.

3) 임신 6 개월 전부터 약 용량 조절이 필요하다.

4) Valproic acid 로 인한 신경관 결손이 2-3 배 일어날 수 있으니 단일용제 최소용량을 사용해야 한다.

5) Valproic acid 나 phenytoin 보다는 carbamazepine 으로 단일용제 처방을 하는 것이 좋다.

19. (야마) 다음 별표에 해당하는 질환은 무엇인가?



1) trisomy 13

2) trisomy 18

3) trisomy 21

4) triploidy

5) 45X

20. 진통 억제제 중 다음과 같은 특성을 가지는 것은?

칼슘길항작용

과량 시 호흡부전

태아 neuroprotective

1) 리토드린

2) 황산마그네슘

3) Terbutaline

21. 초음파 보고 다태임신 종류 고르기



1) MCDA

2) MCMA

3) DCMA

4) DCDA

22. 자궁의 윤곽 파악, 자궁 저부 촉진하고 자궁 옆면을 촉진하고 태아의 팔다리 방향을 확인하는 것으로 양수과다증이 있거나 산모가 비만일 경우 판단하기 어려운 수기는?

1) 레오폴드 수기

2) 맥로버트 수기

3) 리트겐 수기

4) 모리쉐 수기

23. 태아의 BPD 가 골반 입구가 도달했을 때 태아의 하강도는?

1) -2

2) -1

3) 0

4) +1

5) +2

24. 쌍둥이를 임신한 임신 20 주인 33 세 미분만부 산전진찰을 위해 병원에 왔다. 초음파 검사 결과는 다음과 같았다. 적절한 처치는?

	예측 태아몸무게	최대양수수직깊이	태아 성별	탯줄동맥도플러초음파	정맥관도플러초음파
첫째아	400g (10백분위수)	2cm	여아	정상	정상
둘째아	900g (70백분위수)	8cm	남아	정상	정상

1) 추적관찰

2) 양수감압술

3) 양수주입술

4) 사이막절개술

5) 혈관문합 태아경 레이저절제술

25. 임신 39 주 다분만부가 규칙적으로 배가 아랫배가 아파서 병원에 왔다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 75 회/분, 호흡 20 회/분, 체온 36.5 도이다. 골반검사에서 자궁목 1cm 확장, 50% 소실, 하강도 -3 이다. 전자태아심박동-자궁수축감시검사에서 태아 심박동은 정상이고, 진통은 4 분 간격으로 있으나 16 시간 동안 자궁목의 변화가 없다. 진단은?

1) 잠복기지연 (Prolonged latent phase)

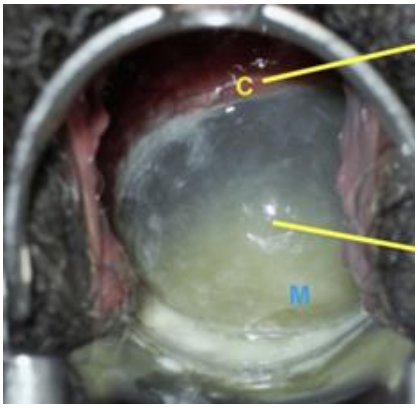
2) 하강지연

3) 아두하강정지

4) 아두하강지연

5) 자궁목 개대 정지

26. 임신 22 주 산모가 아랫배에 묵직한 느낌이 들어 내원하였다. 이전에 유산한 경험이 있었으며 다음과 같았을 때 처치로 올바른 것은?



1) 응급결찰 (Rescue Cerclage)

2) 안정

3) 베타메타손

4) 리토드린

5) 항생제

27. 28 세, 이전에 유산경력이 있었던 7 주 산모가 질출혈을 주소로 내원하였다. 자궁경부는 닫혀있었고 질분비물과 출혈이 관찰되었으며 태아 심박동수는 150 회로 관찰되었다. 유산 종류는?

1) 절박유산

2) 계류유산

3) 불완전유산

4) 완전유산

5) 불가피유산

28. 임신주수 12 주 추정. 생리는 28 일로 규칙적이다. 개인 병원에서 목덜미 투명대 3.5cm 로 추정되어 큰병원 권유받아 내원하였다. 옳지 않은 것은?

1) 부모 염색체검사 함께 시행

2) 초음파로 목덜미 투명대 재검사해야한다.

3) 목덜미 투명대는 CRL 4.5-8.5cm 일 때 측정하므로 초음파로 임신주수 정확히 측정해야한다.

4) 15 주에 Quad test 해서 정상 (2.0-2.5MoM)인지 추정한다.

29. 29 세 32 주 산모가 불규칙한 진통을 주소로 내원하였다. 경부 1cm 열려있었고, effacement 50%였다. (NST 그림도 같이 있었던 걸로 기억함)

1) 리토드린

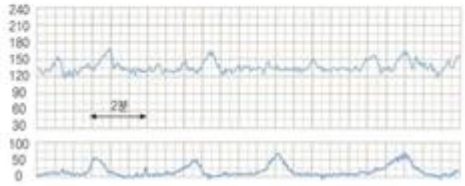
2) 경과관찰

3) 유도분만

4) 제왕절개

30. 임신 39 주인 26 세 미분만부가 규칙적인 진통이 있어서 병원에 왔다. 골반크기는 정상이었고, 예측 태아 몸무게는 3,200g 이었다. 골반검사 결과는 다음과 같았다. 아래 사진은 전자태아 심박동 자궁 수축 감시 검사이다. 알맞은 처치는?

	오전 10시	오전 11시	정오	오후 1시	오후 2시	오후 3시
자궁목 확장(cm)	2	3	5	6	6	6
하강도	−3	−2	−1	0	0	0

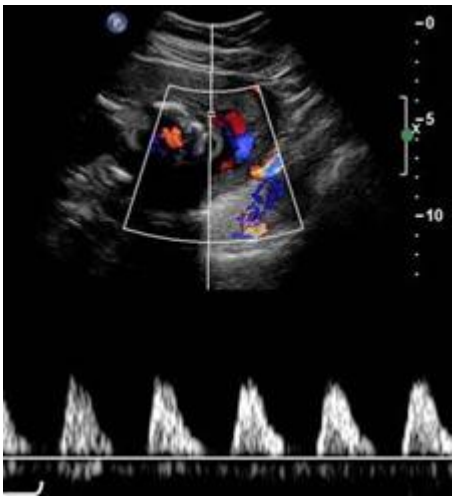


1) 경과관찰

2) 옥시토신

3) 응급제왕절개술

31. 36 세 35 주 산모가 정기검진으로 내원하였다. IUGR 로 진단되었고 양수지수 7 이었다. 다음은 태아탯줄동맥도플러이다. 적절한 처치는?



1) <u>분만</u>

2) 제왕절개

3) 경과관찰

4) 옥시토신

32. 우리나라에서 원칙적으로 허용된 배아 및 태아 유전자 검사에 대한 적응증으로 옳은 것은?

<u>가. 염색체 이상 질환</u>

나. 성인기 발병 단일유전질환 및 가족성 종양

<u>다. 치명적이면서 진단법이 확립된 단일 유전질환</u>

라. 질병 감수성 검사와 보인자 진단 검사

1) 가나다라

2) 가나다

3) <u>가다</u>

4) 나

5) 라